



Triagem de violência contra a pessoa idosa

EASI · SINAIS DE ALERTA E CONDUTA

Paciente _____ Data _____
Quem acompanha _____ Avaliador _____

As cinco primeiras perguntas são feitas **ao paciente, a sós**. A sexta é a impressão do profissional. Garanta privacidade: a presença de quem acompanha inviabiliza a triagem.

Pergunta	Sim	Não	Não respondeu
1. Você depende de outra pessoa para alguma destas atividades: banho, vestir-se, fazer compras, cuidar do dinheiro, alimentar-se?	☐	☐	☐
2. Alguém já o impediu de conseguir comida, roupa, remédios, óculos, aparelho auditivo ou cuidados de saúde, ou de ficar com pessoas com quem você queria estar?	☐	☐	☐
3. Você ficou chateado porque alguém falou com você de um jeito que o fez se sentir envergonhado ou ameaçado?	☐	☐	☐
4. Alguém tentou forçá-lo a assinar papéis ou a usar seu dinheiro contra a sua vontade?	☐	☐	☐
5. Alguém o tocou de uma forma que você não queria, ou o machucou fisicamente?	☐	☐	☐

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

6. **Impressão do profissional.** Você notou, hoje ou em algum momento nos últimos doze meses, algum destes sinais: contato visual evitado, retraimento, desnutrição, problemas de higiene, queimaduras, hematomas, roupas inadequadas, adesão insuficiente ao tratamento ou lesões sem explicação plausível?

☐ Sim ☐ Não

Triagem positiva quando há ao menos uma resposta afirmativa nas perguntas de 2 a 6. Uma triagem positiva não confirma violência: indica necessidade de avaliação mais detalhada e de plano de proteção.

Tipos de violência a considerar

Tipo	O que observar
Física	Lesões em fases distintas de cicatrização, marcas de contenção, fraturas sem mecanismo compatível
Psicológica	Humilhação, ameaça de institucionalização, isolamento imposto, infantilização
Financeira	Uso indevido de benefício, mudança recente de procuração ou testamento, dívidas inexplicadas
Negligência	Desnutrição, desidratação, lesões por pressão, medicação sem uso, faltas às consultas



Tipo	O que observar
Sexual	Lesões genitais, ISTs, comportamento de esquiva ao exame
Abandono	Ausência de responsável, permanência prolongada em serviço de saúde sem retorno

Conduta diante de suspeita

PASSOS

1. Registrar em prontuário de forma objetiva e detalhada, com descrição e, quando possível, documentação das lesões.
2. Avaliar risco imediato e capacidade de decisão da pessoa idosa.
3. Notificação compulsória: a suspeita ou confirmação de violência contra a pessoa idosa deve ser notificada pelo serviço de saúde, conforme o Estatuto da Pessoa Idosa e a ficha de notificação do SINAN.
4. Acionar a rede: assistência social do território, CREAS, Conselho Municipal ou Estadual da Pessoa Idosa, Ministério Público, delegacia. Disque 100 para denúncias.
5. Cuidar também do cuidador: sobrecarga elevada é fator de risco — aplicar a escala de Zarit quando houver essa suspeita.

Registro e encaminhamentos

Dr. Pedro H. Dias Lino

Médico | CRM-7618 | RQE-4251

Referência: Yaffe MJ, Wolfson C, Lithwick M, Weiss D. Development and validation of a tool to improve physician identification of elder abuse: the Elder Abuse Suspicion Index (EASI). J Elder Abuse Negl. 2008;20(3):276–300. • Brasil. Lei 10.741/2003 — Estatuto da Pessoa Idosa. • Ministério da Saúde. Ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada, SINAN.